

Niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **prevención en salud** constituye uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario chileno y del **Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS)**. A través de ella, se busca **evitar la aparición de enfermedades, detectarlas tempranamente y reducir sus secuelas**, garantizando así una atención centrada en las personas y no solo en la enfermedad.

La comprensión de los **niveles de prevención (primaria, secundaria y terciaria)** es esencial para el médico general, tanto en su práctica clínica como en la gestión de salud pública, ya que permite planificar y ejecutar acciones costo-efectivas orientadas a la mejora de la salud poblacional.

En el **EUNACOM**, este tema se evalúa de forma recurrente porque refleja el dominio conceptual del rol médico dentro de la **Atención Primaria de Salud (APS)**, y su capacidad para aplicar estrategias preventivas en distintos escenarios clínicos y comunitarios.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Definición general

“Prevención en salud es el conjunto de acciones dirigidas a evitar la aparición, progresión o complicaciones de enfermedades y otros problemas de salud, mediante la reducción de factores de riesgo y la detección oportuna de alteraciones.”
(OMS, 1984)

La prevención forma parte del **continuum salud-enfermedad**, que abarca promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, según la visión integral del proceso sanitario.

2.2. Distinción entre promoción y prevención

Concepto	Enfoque	Objetivo principal
----------	---------	--------------------

Promoción de la salud	Capacitar y empoderar a las personas para controlar los determinantes sociales y conductuales.	Fortalecer estilos de vida saludables.
Prevención de la enfermedad	Actuar sobre factores de riesgo o detección temprana de enfermedad.	Evitar aparición o progresión de patologías.

Ambas estrategias son **complementarias** y se desarrollan de manera articulada dentro del modelo de atención integral.

2.3. Clasificación de los niveles de prevención

Nivel de prevención	Momento de intervención	Meta principal
Primaria	Antes del inicio de la enfermedad	Evitar aparición.
Secundaria	Fase subclínica o inicial	Detectar y tratar precozmente.
Terciaria	Fase avanzada o crónica	Evitar discapacidad, complicaciones y reinserción social.

3. Prevención primaria

3.1. Definición

Acciones orientadas a **evitar la aparición de la enfermedad** actuando sobre los **determinantes sociales y factores de riesgo**.

3.2. Estrategias principales

1. Promoción de hábitos saludables:

- Alimentación balanceada.
- Actividad física regular.
- Abandono del tabaco y alcohol.

2. Inmunizaciones:

- Vacunas del **Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)**.

3. Prevención ambiental y ocupacional:

- Control de contaminación, riesgos laborales, seguridad vial.

4. Educación sanitaria y participación comunitaria:

- Charlas, ferias de salud, talleres familiares.

3.3. Ejemplos en APS

Intervención	Nivel de prevención
Vacunación contra influenza en adultos mayores	Primaria
Educación sexual en adolescentes	Primaria
Promoción de lactancia materna exclusiva	Primaria
Campañas contra el tabaquismo	Primaria

3.4. Rol del médico general

- Identificar factores de riesgo individuales y familiares.
- Coordinar acciones intersectoriales (escuelas, municipios).

- Liderar campañas y actividades de promoción.
 - Evaluar impacto mediante indicadores de cobertura.
-

4. Prevención secundaria

4.1. Definición

Acciones dirigidas a **detectar precozmente enfermedades** en etapas subclínicas, con el fin de **iniciar tratamiento oportuno y evitar complicaciones**.

4.2. Estrategias principales

1. Tamizajes poblacionales (screening):

- PAP y test de VPH en mujeres.
- Mamografía desde los 50 años.
- Colonoscopia o test de sangre oculta en deposiciones desde los 50 años.
- Pesquisa de HTA y DM2 mediante EMPA.

2. Controles preventivos periódicos:

- Control del niño sano, adolescente, adulto y adulto mayor.

3. Diagnóstico precoz mediante vigilancia activa:

- Búsqueda de casos índice y trazabilidad.

4.3. Ejemplos en APS

Intervención	Nivel de prevención
Toma de PAP y test de VPH	Secundaria

Control de presión arterial en consulta Secundaria

Medición de glicemia capilar en EMPA Secundaria

Detección de depresión en adolescentes Secundaria

4.4. Rol del médico general

- Aplicar tamizajes según normativa ministerial.
 - Interpretar resultados e iniciar tratamiento.
 - Garantizar derivación y contrarreferencia.
 - Notificar enfermedades de vigilancia obligatoria (DEIS).
-

5. Prevención terciaria

5.1. Definición

Intervenciones destinadas a **evitar secuelas, discapacidades o recaídas** una vez instaurada la enfermedad, promoviendo la **rehabilitación y reinserción social**.

5.2. Estrategias principales

1. Rehabilitación física y funcional:

- Terapias kinésicas post-ACV o fracturas.

2. Rehabilitación psicosocial:

- Apoyo a pacientes con trastornos mentales o adicciones.

3. Control de enfermedades crónicas:

- Programa de Salud Cardiovascular (PSCV).

- Seguimiento de DM2, HTA y dislipidemias.

4. Prevención de complicaciones:

- Cuidado del pie diabético, vacunación en inmunodeprimidos.

5.3. Ejemplos en APS

Intervención	Nivel de prevención
Programa de rehabilitación post-ACV	Terciaria
Taller de autocuidado para diabéticos	Terciaria
Control y seguimiento de enfermedad crónica	Terciaria
Reintegración laboral tras enfermedad ocupacional	Terciaria

5.4. Rol del médico general

- Garantizar continuidad del cuidado.
- Coordinar equipo interdisciplinario (kinesiólogo, psicólogo, nutricionista).
- Monitorear adherencia terapéutica.
- Promover inclusión social y laboral.

6. Prevención cuaternaria (concepto emergente)

6.1. Definición

“Acciones que evitan la sobreintervención médica y los daños derivados de procedimientos innecesarios.”

(WONCA, 2011)

6.2. Ejemplos

- Evitar prescripción excesiva de antibióticos.
- No indicar exámenes innecesarios en pacientes asintomáticos.
- Evitar sobrediagnóstico de hipertensión o dislipidemia.

Este nivel, aunque no clásico, es fundamental para la **ética médica moderna y la seguridad del paciente**.

7. Aplicación práctica en el contexto chileno

En Chile, la prevención se estructura transversalmente en los **Programas de Salud Prioritarios (PSP)** y en el **Modelo de Atención Integral (MAIS)**:

Nivel de prevención	Ejemplo programático
Primaria	Promoción de lactancia, PNI, Vida Sana.
Secundaria	EMPA, PAP, mamografía, pesquisa cardiovascular.
Terciaria	Programa de rehabilitación integral y salud mental.

El **médico general en APS** es el principal responsable de ejecutar estas acciones, reportarlas y coordinar su continuidad en la red asistencial.

8. Enfoque de riesgo y determinantes sociales

La prevención debe adecuarse al contexto social y territorial:

- Personas con menor educación, pobreza o ruralidad requieren **intervenciones reforzadas**.
 - Factores ambientales (contaminación, vivienda inadecuada) influyen en el éxito preventivo.
 - La **intersectorialidad** con municipios, educación y desarrollo social es esencial.
-

9. Rol del médico general en los niveles de prevención

Función	Descripción
Educador sanitario	Promueve estilos de vida saludables.
Evaluador de riesgo	Identifica factores individuales y familiares.
Ejecutor de tamizajes	Aplica PAP, EMPA, control de presión y glicemia.
Coordinador de cuidados	Articula seguimiento y contrarreferencia.
Gestor comunitario	Participa en ferias, escuelas y mesas intersectoriales.
Vigilante epidemiológico	Registra, notifica y analiza eventos de salud.

10. Indicadores epidemiológicos asociados

- Cobertura de PAP y mamografía.
- Porcentaje de adultos controlados por HTA y DM2.

- Cobertura de vacunación infantil y antigripal.
- Porcentaje de EMPA y EMPAM realizados.
- Tasa de incidencia de enfermedades prevenibles.

Estos indicadores son monitoreados por el **DEIS (Departamento de Estadísticas e Información de Salud, MINSAL)**.

11. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Confundir promoción con prevención	La promoción busca empoderar; la prevención actúa sobre riesgos específicos.
Pensar que la prevención secundaria solo ocurre en hospitales	Se realiza principalmente en APS mediante tamizajes.
Asumir que la prevención terciaria no es función del médico general	En APS, el seguimiento crónico y la rehabilitación básica son claves.
Omitir la prevención cuaternaria	Es parte del enfoque ético moderno en salud.
Creer que los tres niveles son independientes	Son complementarios y dinámicos en la práctica.

12. Normativa chilena y documentos ministeriales

- MINSAL (2013). Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria (MAIS).

- MINSAL (2021). Política Nacional de Salud 2021–2030.
 - MINSAL (2022). Manual de Programas de Prevención y Promoción.
 - OPS/OMS (1986). Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud.
 - WONCA (2011). Prevención Cuaternaria y Ética Médica.
-

13. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Los **niveles de prevención** (primaria, secundaria y terciaria) son el núcleo operativo de la atención en salud pública y APS.
2. La **prevención primaria** evita la aparición de enfermedades mediante promoción e inmunización.
3. La **prevención secundaria** detecta precozmente enfermedades para intervenir oportunamente.
4. La **prevención terciaria** busca reducir secuelas, discapacidad y mejorar calidad de vida.
5. La **prevención cuaternaria** protege al paciente de intervenciones innecesarias y daños iatrogénicos.
6. El **médico general** tiene un rol integral: educador, pesquisador, tratante y coordinador de redes.
7. En el **EUNACOM**, es frecuente evaluar la correcta clasificación y aplicación de intervenciones preventivas según nivel.